

ESCRITO CLÍNICO · DANIEL OROZCO ABIA

Yo fragmentado

Borderline y esquizoide en Freud, Kernberg y Kohut.

TEXTO TEÓRICO DE REFERENCIA · 5 SECCIONES · TWIM PROJECT

CONTENIDO

- I Freud · la escisión como condición estructural
- II Kernberg · estructura, no síntoma
- III Kohut · déficit, no conflicto
- IV Diagnóstico diferencial · uso clínico directo
- V Donde se confunden · el riesgo clínico real
- VI Matiz · la dirección del movimiento bajo amenaza

I · FREUD

La escisión como *condición estructural*

La Spaltung (1938, Esquema del psicoanálisis) no es represión. En la represión, el contenido inaceptable desaparece de la consciencia. En la escisión, dos posiciones contradictorias

coexisten sin integrarse. El yo las sostiene simultáneamente sin que colisionen. Eso es posible porque **el yo ha renunciado a su función sintética**.

La diferencia clínica fundamental respecto a la neurosis es la naturaleza de la angustia primaria. El neurótico opera bajo angustia de castración —amenaza de pérdida de algo que se tiene. En las organizaciones pre-neuróticas, la angustia es de aniquilación del yo mismo.

No castración. Desintegración.

Esto cambia todo el campo técnico: el objetivo no es hacer consciente lo reprimido sino **reconstruir un yo que nunca logró integración**.

II · KERNBERG

Estructura, *no síntoma*

La difusión de identidad como marcador diagnóstico

Kernberg no parte del síntoma sino de la estructura. La pregunta no es qué le pasa al paciente sino cómo está organizado su mundo interno. El indicador central en la organización borderline es la **difusión de identidad** (identity diffusion): el paciente no puede construir una imagen coherente y estable de sí mismo ni del otro.

Test clínico directo: «Descríbeme cómo eres tú.» En organización neurótica, la respuesta es compleja pero coherente. En organización borderline, emergen contradicciones irresolubles sin que el paciente las registre como tales. «Soy muy generoso pero también soy bastardo cuando me tocan.» Sin puente. Sin integración.

Mecanismos de defensa nivel borderline

La escisión es el eje, pero no opera sola. Los mecanismos asociados definen dos perfiles distintos.

BORDERLINE

- **Identificación proyectiva:** deposita en el terapeuta aspectos del self que no puede tolerar, y luego actúa sobre ese terapeuta para confirmar la proyección. Esto es activo, relacional, requiere al otro.
- Idealización primitiva / devaluación alternante.
- Negación de sectores de experiencia.
- Omnipotencia.

ESQUIZOIDE

- **Retirada de las relaciones de objeto.** No identificación proyectiva activa: el esquizoide no necesita al otro para su defensa, sino que lo elimina del campo.
- Intelectualización como sustituto del contacto afectivo.
- Mundo interno rico en fantasía; empobrecimiento del vínculo real.

La diferencia estructural es esta: el borderline usa al objeto como contenedor y regulador. El esquizoide prescinde del objeto real. Ambos están en organización borderline de personalidad — no psicóticos, prueba de realidad conservada— pero **la dirección del movimiento defensivo es opuesta.**

Relaciones de objeto internalizadas

Kernberg describe las unidades básicas del mundo interno como díadas: representación del self + representación del objeto + afecto que las une. En organización borderline, esas díadas

permanecen escindidas: hay una díada de self bueno / objeto bueno y una de self malo / objeto malo, sin síntesis. El cuidador que nutre y el que frustra no se integran en el mismo ser.

Resultado clínico: idealización absoluta que colapsa en devaluación absoluta sin transición ni causa proporcional. **No es inconsistencia moral. Es funcionamiento estructural.**

En el esquizoide, las díadas están igualmente dissociadas, pero la investidura afectiva de las relaciones reales es mínima. La energía se vuelca en objetos internos, fantaseados. La relación con el terapeuta amenaza ese mundo interno protegido.

III · KOHUT

Déficit, *no conflicto*

El self que no se consolidó

Kohut desplaza el eje del conflicto pulsional al **déficit estructural**. El self adquiere cohesión a través de tres tipos de experiencias con selfobjects:

- 1 **Espejamiento** (mirroring): ser visto, confirmado, reconocido en la propia grandiosidad.
- 2 **Idealización**: poder apoyarse en una figura percibida como fuerte y estable.
- 3 **Gemelaridad** (twinship): sentir que alguien es fundamentalmente como uno.

Cuando estas experiencias fallan de manera sistemática y temprana, el self no alcanza solidez. Queda vulnerable a la **fragmentación**: pérdida de la sensación de ser un yo continuo bajo presión relacional o narcisista.

Borderline desde Kohut

El paciente borderline no tiene un conflicto edípico mal resuelto. Tiene un self que nunca se reguló internamente y que busca en el objeto externo la función reguladora que debió internalizarse. La intensidad relacional borderline no es capricho ni manipulación: **es necesidad estructural**.

La **rabia narcisista** —diferente de la rabia reactiva— emerge cuando el selfobject falla. Es desproporcionada a los ojos del otro porque no responde al episodio presente sino al agravio primitivo de no haber sido visto. El terapeuta que llega tarde, que se va de vacaciones, que no parece entender: activa el déficit original.

El self grandioso en el borderline es un intento de cohesión compensatoria. No narcisismo secundario defensivo en el sentido kernbergiano, sino frágil estructura de sostén.

Esquizoide desde Kohut

Kohut describe dos orientaciones del self patológico ante la necesidad de selfobject:

- **Tipo A:** búsqueda activa de fusión (más cercano al borderline).
- **Tipo B:** terror al merger, retiro preventivo.

El esquizoide ha aprendido que la exposición al selfobject produce aniquilación del self frágil, no su consolidación.

El contacto no restaura: destruye.

La solución es proteger el núcleo del self —empobrecido pero propio— detrás de una muralla de distancia.

Esto es crucial clínicamente: la frialdad esquizoide no es ausencia de vida interior. Es protección intensa de un mundo interno que el paciente percibe como la única realidad segura.

IV · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Tabla de *uso clínico directo*

VARIABLE	BORDERLINE	ESQUIZOIDE
Angustia primaria	Abandono / separación	Engullimiento / fusión
Lo que amenaza	La distancia del otro	La cercanía del otro
Mecanismo central	Identificación proyectiva	Retirada del objeto
Necesidad del otro	Urgente, estructural	Prescindible, amenazante
Identidad	Difusa, fragmentada en el ruido	Aislada, fragmentada en el silencio
Transferencia	Intensa, oscilante, con acting-out	Distante, idealización intelectual
Vacaciones / ausencias	Crisis, regresión, acting	Alivio o indiferencia aparente
Silencio en sesión	Angustiante; lo llena o lo usa como agresión	Confortable, a veces preferido
Vida interior	Caótica, vuelca al exterior	Rica en fantasía, raramente expuesta
Mahler (fijación)	Rapprochement	Diferenciación / simbiosis temprana

El *riesgo clínico* real

Ambos presentan relaciones poco estables y un yo sin cohesión aparente. El **error frecuente** es leer la distancia esquizoide como defensa borderline —como si el paciente estuviera «guardándose» para atacar después. No. El esquizoide no está activado relacionalmente en segundo plano: **está ausente del campo relacional por necesidad defensiva**.

El **segundo error** es invertir la técnica. Con el borderline, la cercanía regulada sostiene. Con el esquizoide, la cercanía prematura produce huida o disociación. El punto de trabajo con el esquizoide no es el vínculo con el terapeuta —eso es demasiado peligroso desde el inicio— sino el mundo interno fantaseado que sí puede nombrarse sin que amenace la distancia protectora.

La pregunta técnica diferencial no es «¿tiene rasgos borderline o esquizoides?», sino:

PREGUNTA-EJE

*¿Qué es lo que este paciente teme más:
que me vaya, o que me acerque?*

Eso orienta la transferencia. Y la transferencia orienta todo lo demás.

La dirección del *movimiento bajo amenaza*

La pregunta-eje de la sección anterior («¿teme que me vaya o que me acerque?») es correcta como entrada, pero **la clínica real complica la respuesta lineal**.

Borderline · necesidad y amenaza simultáneas

Teme que te vayas. Y también puede temer que te acerques demasiado, porque la cercanía extrema amenaza los límites del self. La dinámica no es lineal: **necesita la presencia y a la vez la presencia activa la angustia de fusión**. Por eso el ciclo clínico oscila entre aferramiento e impulso de ruptura. Kernberg lo lee como escisión activa: el mismo objeto idealizado colapsa en objeto persecutorio sin causa proporcional.

Esquizoide · el dilema de Fairbairn

Teme que te acerques. Pero hay algo más preciso, que Fairbairn formuló como **el dilema esquizoide**: también necesita el vínculo, pero necesitarlo es peligroso. No es indiferencia. Es necesidad que no puede moverse hacia el objeto sin activar angustia de aniquilación del self. La solución es la retirada, no la ausencia de deseo.

Lo observable · dirección del movimiento

La diferencia operativa no está solo en qué teme cada uno, sino en **qué dirección se mueve cuando siente amenaza**:

- **Borderline bajo amenaza**: se acerca más, ataca, actúa. Movimiento hacia.
- **Esquizoide bajo amenaza**: desaparece, se cierra, se va. Movimiento desde.

Eso es lo observable en sesión sin necesidad de teoría:

PREGUNTA-GESTO

Cuando algo duele, ¿este paciente te busca o te borra?

Esa pregunta, junto a la anterior, cierra el circuito diagnóstico. Una mira al miedo. La otra mira al gesto. Las dos juntas previenen los dos errores técnicos descritos en la sección V.

Daniel Orozco Abia

PSICÓLOGO GENERAL SANITARIO · CV11515 · TWIM PROJECT